

01 ta 每天刷到的

这些词 ta 每天都在读。 读得够多，就成了自己的声音。

女性终生患病率

3.5%

暴食障碍。高于贪食症 1.5% 和厌食症 0.9% 之和。

大样本女性中

7.04%

筛查阳性。而诊断率低、就诊晚、治疗只盯着体重。

中国

约两倍

贪食症的患病率约为厌食症的两倍，而且三十年一直在涨。

Hudson 2007 NCS-R · GBD 2019 · 中国健康与营养调查
背景词取自公开可检索的常见说法与搜索词，不是引用任何具体的人

暴食后悔 我太差了 热量差 体脂率

自律

只能吃一点 明天再说

好胖

筷子腿

刷脂

吃了会胖

恶心

不吃了 食物是罪恶的

管不住自己

体重焦虑

意志力 少吃一口

清肠

这个点， ta 能打开的东西一共三样。

热线	要开口	+
24 小时都在。代价是这件事从此有一个人知道了。		
咨询	要建档	+
工作日白天。而且要留下一份关于你的记录。		
热量 App	不需要开口	+
唯一在这个点还开着、又不需要 ta 向任何人开口的。105 名确诊者中约 75% 在用它 —— 其中 73% 认为它加重了自己的病。		

越是看起来没问题的人，越不能让人知道自己有问题。
Levinson et al. 2017 · 横断面与自我报告，只讲关联与主观归因，不讲因果

市面上的产品，要么给 ta，要么给 ta。
退潮两端都做——而且互相看不见。

照护者看见行为 → 读成浪费、撒谎、不听话 → 批评 → 沟通失败 → ta 为了避免冲突转入更隐蔽的做法 → ta 更警觉 → 冲突升级。

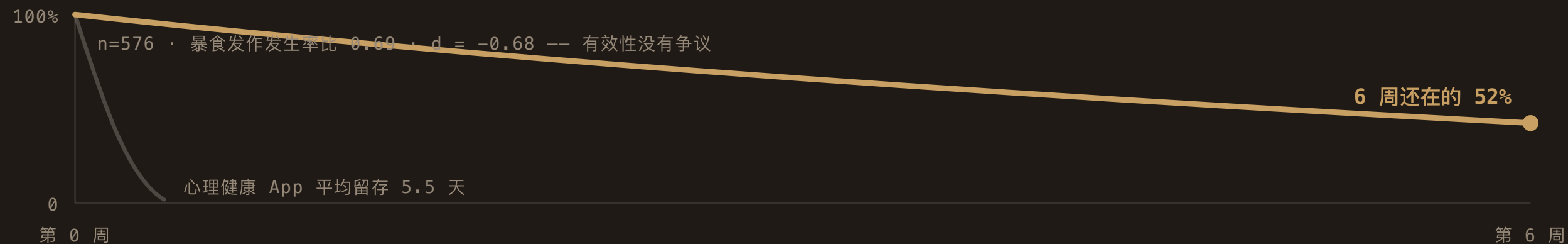
这条链上缺的从来不是爱。是翻译。

所以照护者端的核心不是话术库，是行为翻译器。

而最该告诉 ta 的一句是：你的批评，正在生产你想制止的那个行为。

要解的不是有效性，是留存。

有效性早就被大样本 RCT 证实了。问题在后半句。



脱落

48%

同一项研究，六周内脱落。只有三分之一的人走完。

meta 级背书

279,791 人

117 项试验的结论：留得住人的，有提醒、有人在，且没有游戏化。

现有方案是纯心理的， 躯体那一层是空的。

发作之后身体会发生一串具体的事。它们会被误读，而每一次误读都是下一轮的引信。

身体在做什么

糖原结合水

吃了一顿，秤上会重。那是水。

ta 读成 → 我胖了

身体在做什么

反跳性水肿

停下来之后会肿，三四天开始，两三周退。

ta 读成 → 停了就胖，于是又吐了回去

谁在处理

没有人

调研过 30 多个产品。查「清除后护理」，出来的全是论文和医院科普页——消费级产品一个都没有。

这一层是营养学能接住、而心理干预接不住的

暴食是最大的那一群， 也是最不被看见的那一群。

女性终生患病率 Hudson 2007, NCS-R



全球

全球疾病负担研究没把暴食障碍单独算进去。人最多的这一侧，连一个口径都没有。

中国

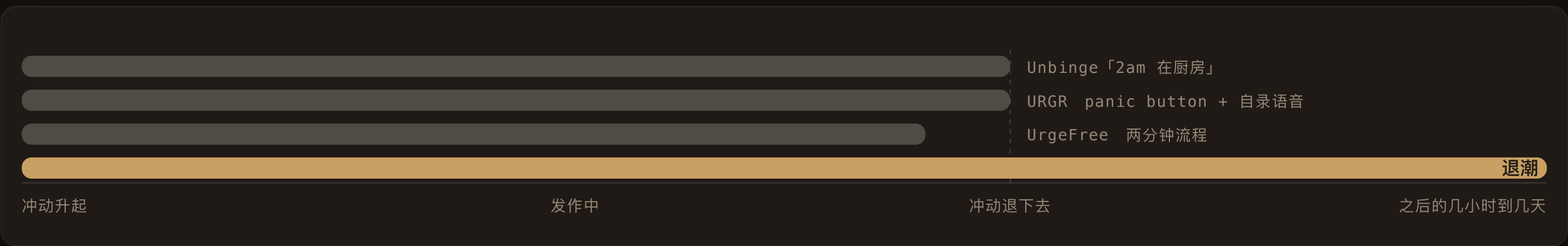
贪食症的患病率约为厌食症的两倍，而且这三十年一直在涨。

而且

2024 年的诊疗共识已经有了。不是没人管——是诊断率低、就诊晚、只盯着体重。

急性期入口已经被占了。 但做的人都停在冲动退下去为止。

2025 下半年到 2026 冒出一批「时刻介入」的 app。
真正空着的不是入口，是**冲动退下去**之后。



还有一个免费的

OA 线上会议：可假名、只听不说。差别不在价格——它要你戒断某类食物，而戒断就是限制，限制就是引信。

我们在哪一段

冲动退下去之后。身体正在发生什么，哪些必须去医院。那一段没有任何消费级产品在做，也没有一个同时做照护者。

05 产品主张

这个产品里没有人。 但屏幕上有一个数字会自己变。

没有账号，没有咨询师，没有人会知道你来过。
因为求助之所以难，是求助这个动作本身就是暴露。

所以

无账号、无登录、双端硬隔离

所以

定时小组零发言、不显示别人

所以

不做论坛、不做用户互动、不配对

唯一的例外

「此刻 23 人在」
整个界面唯一会自己变的数字。

为什么偏偏留它：情绪通向暴食这条路，中间那一站是孤独（Southward 2013，n=107）。
人数是 0 或 1 时整块不显示——凌晨三点看到「还有 0 个人」，比看不到更糟。

六格记的是缺口，不是成绩。

三顿正餐 + 三次加餐，隔三到四个小时。

空格是虚线，不是红色——空着不是失分，是提醒。

情绪是预警，所以要有回应

「空 / 孤单 / 羞耻 / 紧张」这几个词记下之后会多一句话，把晚上那场摆到手边。

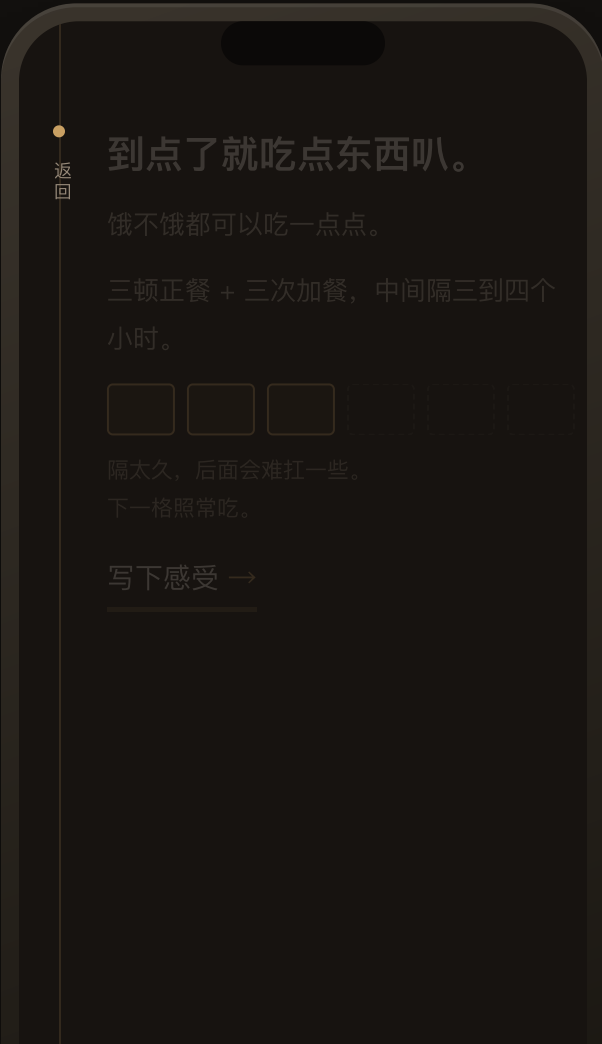
因为发作前四个小时，这些词会变密。

第二组词是滋味

咸 甜 烫 脆 香 软 酸 辣 凉 鲜。

只描述，不评价——一评价就会招来评判。

记完只回一句：「记下了。但这只是一个词，它不代表对你的任何评价。」



ta 写一句，四个人各回一段。这是真的生成式对话。

而这个领域刚栽过。我们的答案不是「不做」，是三道护栏。

一 · 四条窄路

四个人各自只能说很窄的一类话。四条窄路，比一条宽路安全。

二 · 说完再查一遍

提示词是请求，检查才是保证。

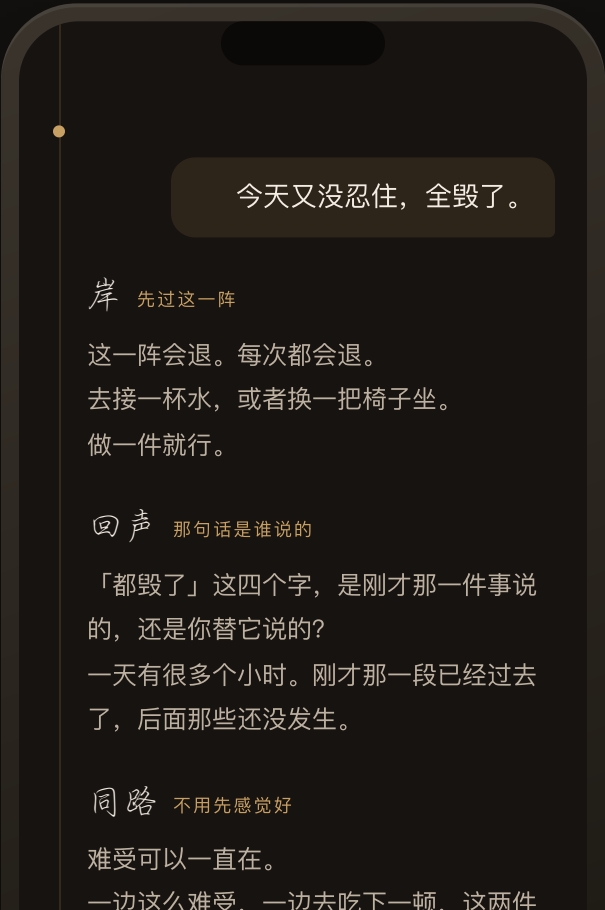
数字、份量、评价身体、劝人吃什么、夸奖、打比方——碰到一条，这段话就不上屏。

三 · 不合格就换人写的

不重试，也不改写。

改写等于在有害的话上打补丁，而补丁过的那句，仍然是模型写的。

为什么必须这样：Pucci 2026 临床标注的 268 个回答里只有 44.7% 是安全的，而且「免责声明之后照样给建议」是最常见的一种失败。不能靠模型自己声明安全。



这一层原本整个产品里是空的。

一天一条，只写这一样东西尝起来什么样。
不出现热量、份量、健康与否，也不出现「好吃」。

为什么这么写

有些东西 ta 已经很久不敢吃了。
要让它变回普通食物，办法不是劝 ta 吃，**是先让 ta 想起它是什么味道。**

三十张插画，每张的颜色取自那道菜本身 · 卡上没有任何数字 · 右边可以翻到整面墙，点任意一张展开



你来了，你吃了没？

首页只有一个入口：「我现在不太好」。

点进去才分岔。这句话不预设你是谁，所以厌食、贪食、说不上来的人都能说。

这不是安慰，是因果

有个实验：吃下「不该吃」的食物之后，只给一句不评判的话，人就不会接着「反正已经毁了」吃下去。

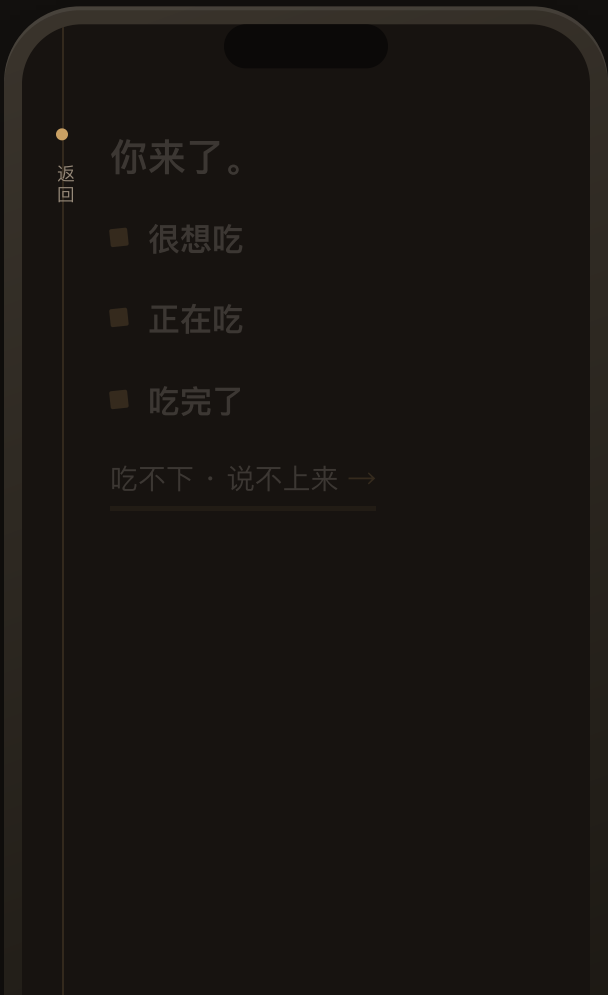
变量只有那一句话。

所以这些话是写死的

它是干预本身，不是文案。这一层不接生成式对话。

Adams & Leary 的实验 · 这一屏还有一句：「现在这一页上，还有 12 个人。谁也不知道谁是谁。」

因为羞耻的核心是「只有我这么坏」。



没有人提前告诉过 ta。

所以 ta 又吐了回去。

屏上说的

「一般三四天开始，两三周退掉。」
「水一小口一小口喝——别猛灌，身体这几天存水。」

屏上不说的

那个精确到小数点的换算。它是我们做判断的依据，产品里一次都不出现。

边界

什么时候必须去医院，有一张清单。**但不诊断、不打分、不给剂量**——刻意停在医疗器械之外，所以现在就能跑。

还有一条：吐完先别刷牙，那会磨掉牙釉质 · 到了医院可以直接说：想查电解质和心电图

返回

结束了。

现在想去抵消掉刚才那顿的话，先别。那条路事后更难。

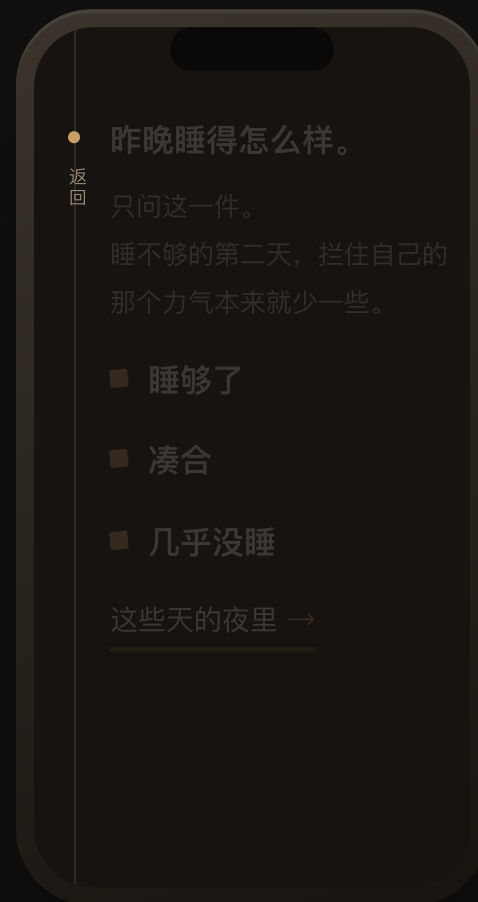
先看看身体。

- 有点不舒服
- 还行

有三件事看起来像那么回事 →



提醒、有人在、不打分。 留存证据直接指的就是这三样。



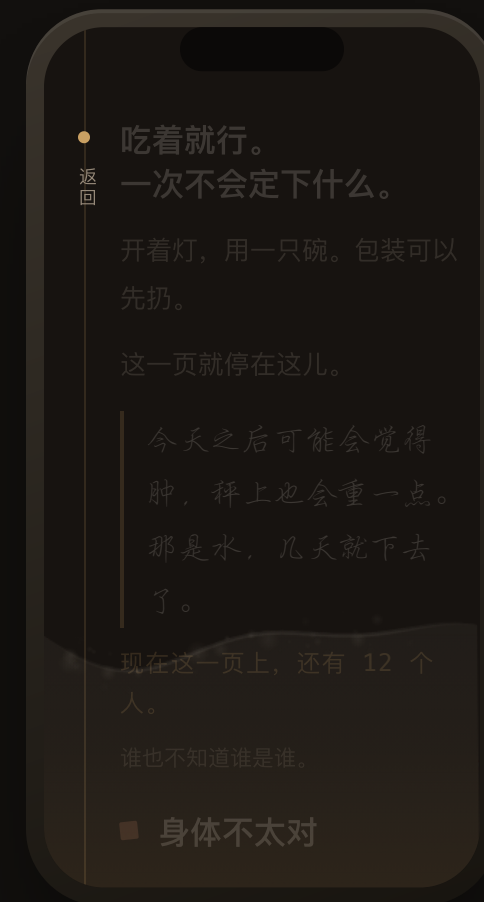
睡眠 · 点进星空

一晚一颗星。亮度是那一晚的样子，不是评分。



一起正念 · 点进课程

固定三场，到点进来。不说话、不显示别人、结束不评分。



发作那一屏 · 还有 12 个人

匿名和「有人在」不冲突。

它不暴露任何人，却正好打在孤独上。

Zainal et al. 2025, 117 项试验：留得住人的，有提醒、有人在、没有游戏化。

这三件正好是那三个条件——「没有游戏化」就是我们砍掉进度条的依据。

七张翻译卡，每张一段。

开场那一句，就是其中一张。

每张三段：你会怎么想 → 真实是什么 → 现在做什么。

七张卡共用的那一句

「你看见的每一个行为，都不是它看起来的那个意思。」

这不是安慰。把行为读成品行、然后批评，是这个病最常见的加速器。

最容易读错的两处

脸肿，和手背指关节上的茧。

那几天评论外形的风险最高，一句都不要说。

如果只记一件事：正在发生的时候不要对质。

要谈，挑一个不挨着饭桌、也不挨着卫生间的时间。

ta 的动作是什么意思。

每一张三段：你会怎么想、真实是什么、现在做什么。

ta 把饭倒进了垃圾桶 →

ta 问「我是不是很胖」 →

ta 说「我吃过了」 →

家里的食物少了 →

深夜 ta 一个人在厨房 →

ta 饭后在卫生间很久 →

ta 情绪突然掉下去 →

不给人贴标签。

五种最常见的反应，加两种理想的。
每一种都有名字，而名字给的是反应，不是人。

最难的那一句，在「梗犬」那张

「提醒的次数越多，ta 越需要藏。

你想制止的那个行为，正在被你的关心推着往隐蔽处走。」

三 · 学习资料做成流，不做库

一天一条，看过就好。

做成库没用——实测里有 20.6% 的人从没打开过任何模块。

动物名来自 New Maudsley Model，Beat 官方推荐。 卡片正文一次「你是」都不出现——动物是可查的记法，不是贴在人身上的标签。



匿名不只是承诺，它是架构。

没有账号，就没有登录、鉴权、资料、关系、权限。

记录、情绪、滋味**全部存在手机里，数据不出设备**——既是隐私，也省掉了整个后端。

形态

微信小程序

扫码即用

规模

62 屏可跑

每一屏都不用滑

后端只有两处

在场人数、四个人的生成。**不存任何用户输入**——ta 写的话，用完就没了。

模型选型也是判断

换掉会「先思考」的模型之后，**四个人一起回应，3.3 秒。**

自检脚本每次构建都扫一遍全部屏幕：**患者端一个临床词都不许出现**——症状、患者、病人、疾病、治疗、康复、诊断。

每一条都标了级。有争议的，我们讲争议本身。

已查证

能核到原始记录的，才上台讲。

不讲的

中文网络上的名言错标率极高，所以产品里不引用任何人。

有争议

限制型厌食里约四到六成会走到暴食。文献从 42% 到 62% 都有——我们讲区间，不讲上限。

一个数字要能上屏，先得说清它不能证明什么。

这条对产品同样成立——所以屏幕上一个热量数字都没有。

在这个领域，不走的路比能走的路更能体现判断。

不走

不收订阅。
凌晨三点弹一个付费框，会触发「我连这个都要花钱」的羞耻。

不走

不做广告。
进食障碍用户 + 广告定向 = 减肥广告精准投放。

不走

不做数据变现。

不走

不把急性期的人导去按分钟收费的咨询。

主模型 · 让付费方不是脆弱的那一方

机构授权：高校心理中心 / 专科的院外延伸 / 企业 EAP。
大学生里高发，而学校没有专门工具。

已降级 · 只作假设不作结论

照护者端付费。**不知道的人不会去搜索**，而且双端隔离意味着付费方看不到效果。
这一条是假设，不是结论。

患者端永远免费，不做广告，不做数据——这是产品伦理，不是暂时策略。
收入来自不脆弱的那一侧。刻意停在监管边界之内，所以现在就能跑。

已经有人证明了这套方法有效。
没有人解决为什么没人用完，
也没有人管发作之后
身体发生了什么。

我走的是限制那一段。那条路上有相当一部分人最后走到了暴食，我是没走到那一步的那一半。

产品里有几句话，是当年有人对我说过的。

食物、爱
与生命